

Groupe 1 - Version D

Durée : 45 minutes

I-QCD

Répondre par A pour la proposition juste et B pour la proposition fausse

(une réponse juste= 1point – une réponse fausse = - 1 point – une question sans réponse = 0)

- Q1. En région d'endémie, la notion d'un syndrome dysentérique, d'une rectorragie ou même simplement d'une diarrhée prolongée doit faire effectuer une recherche d'amibes
- Q2. La coqueluche est une toxi-infection contagieuse non immunisante
- Q3. La maladie de Bouillaud succède à une angine à streptocoque le plus souvent banal, érythémateux ou érythémato-pultacée.
- Q4. La RAA n'est nullement un essaimage microbien à partir du foyer infectieux
- Q5. La chorée n'atteint pratiquement que les jeunes filles pré-pubères.
- Q6. L'appareil venimeux des serpents comprend essentiellement deux glandes qui synthétisent le venin et un système d'injection constitué par des dents modifiées en crochets.
- Q7. La poliomyélite est une maladie du péril fécal.
- Q8. La giardiose entraîne des signes digestifs, mais le portage asymptomatique est fréquent.
- Q9. La tuberculose uro-génitale est une infection tuberculeuse du poumon par voie hématogène à partir d'un foyer pulmonaire, pleural, lymphatique ou indéterminé.
- Q10. Tous les germes pathogènes peuvent être responsables de péricardite.

II- QCM

(une réponse juste= 1point – une réponse fausse = 0 point – une question sans réponse = 0)

- Q11- L'état de mal asthmatique se caractérise par l'existence de signes de gravité qui sont: Cocher l'intrus
- A Une dyspnée intense avec tirage sus sternal et intercostal
 - B Une cyanose des extrémités
 - C Un ictère franc
 - D Tachycardie à plus de 130 battements par mn
 - E une attaque d'asthme prolongée et trop longtemps négligée et trop tardivement traitée.
- Q12. Les arthrites infectieuses sont liés à : cocher la proposition juste
- A L'absence de germes dans l'articulation
 - B la présence de germe dans l'articulation qu'il soit bactérien, parasitaire, mycosique ou virale.
 - C la présence de germe dans l'articulation qu'il soit bactérienne et virale
 - D la présence de germe dans l'articulation qu'il soit parasitaire et mycosique .

Q13. Parmi les signes suivants, indiquez celui qui traduit la localisation pulmonaire de la tuberculose

- A La toux
- B La fièvre
- C L'amaigrissement

Q14. Parmi les vers suivants, indiquez celui qui est un cestode

- A L'ankylostome
- B L'anguillule
- C Le ténia

Q15. Parmi les parasites ci-dessous, indiquez les deux qui se transmettent par voie transcutanée

- A L'oxyure
- B L'anguillule
- C L'ascaris
- D L'ankylostome

Q16. Dans la diphtérie la localisation laryngée ou croup se traduit par : Cocher la proposition exacte

- A une toux, une voix rauque s'éteignant progressivement - Une bradypnée inspiratoire et des crises d'asphyxie.
- B une toux, une voix bitonale s'amplifiant progressivement - Une bradypnée expiratoire et des crises d'asphyxie.
- C une toux, une voix sèche, totalement éteinte - Une bradypnée paroxystique et des crises d'asphyxie.

Q17. Les complications de la néphropathie gravidique ajoutée présente les caractéristiques suivantes sauf deux. Cocher ces deux intrus

- A elles apparaissent dès les « premiers mois » de la grossesse
- B elles peuvent survenir lors de n'importe quelle grossesse
- C les signes sont passagers et disparaissent après l'accouchement
- D la guérison n'est pas complète après l'accouchement
- E les accidents récidivent lors de grossesses ultérieures et ont tendance à s'aggraver
- F elles apparaissent au dernier trimestre chez les multipares

Dans les cas néphropathie gravidique ajoutée, Le pronostic fœtal est, dans l'ensemble mauvaise.

Q18. Les facteurs de risque de néphropathie gravidique sont : Cocher les deux propositions non exactes

- A l'existence d'antécédents personnels ou familiaux de surpoids ;
- B Les femmes de petites tailles
- C l'hypercholestérolémie ;
- D Le diabète
- E Les femmes ayant un bassin généralement rétréci
- F l'hypertension artérielle ou le tabagisme.

Q19. Pour les gestes de premiers secours chez un sujet déclarant une morsure de serpent, il faut : cocher les deux gestes à ne pas faire

- A rassurer le patient et son entourage,
- B Poser un garrot
- C nettoyer la morsure et rechercher les traces de crochets
- D Appliquer une pierre noire absorbante de venin
- E faire un examen général pour évaluer la gravité.
- F distinguer les signes de stress des symptômes d'envenimation

Q20. L'évolution de la poliomyélite s'accompagne de séquelles qui sont: Cocher les deux intrus

- A les rétractions tendineuses
- B les fentes labiales
- C l'amyotrophie qui
- D la scoliose
- E les pieds-bots
- F La lordose

Q21. La poliomyélite évolue sur deux formes essentielles. Lesquelles ?

- A Forme paralytique
- B Forme cardiaque
- C Forme digestive
- D Forme respiratoire
- E Forme neuro-psychiatrique

Q22. La confirmation du diagnostic de la poliomyélite repose généralement sur: Cocher la bonne proposition

- A la mise en évidence de poliovirus dans un prélèvement de sang ou dans les sécrétions nasales.
- B la mise en évidence de poliovirus dans un prélèvement des crachats ou dans les urines.
- C la mise en évidence de poliovirus dans un prélèvement de selle ou dans la gorge.

Q23-Le traitement curatif de la méningite purulente est basé sur : choisir la proposition juste

- A- Une antibiothérapie bactériostatique
- B- Des antalgiques et antipyrétiques majeurs
- C- Des diurétiques
- D- Une antibiothérapie bactéricide à large spectre

Q24-Dans la rage humaine les signes pathognomoniques associés à un tableau d'encéphalite sont les suivants : (cocher les 2 bonnes réponses)

- A- Signes de koplick
- B- Aérophobie
- C- Hyper excitabilité
- D- Hydrophobie

Q25- Dans une pneumonie franche lobaire aigue(PFLA),on observe deux signes physiques parmi les propositions suivantes. lesquels ?

- A- Cyanose
- B- Souffle cardiaque
- C- rougeur bilatérale des pommettes
- D- Hypocratisme digital
- E- herpès naso-labial du au pneumocoque.
- F- Râles sibilants

Q26 -La vaccination antitétanique efficace chez l'adulte nécessite une injection de : cocher la proposition juste.

- A- 3 doses de 1 mois d'intervalle suivies de 1 rappel à 1 an puis tous les 5 ans.
- B- 4 doses de 1 mois d'intervalle suivies de 1 rappel à 1 an puis tous les 5 ans.
- C- 2 doses de 1 mois d'intervalle suivies de 1 rappel à 1 an puis tous les 5 ans

Q27 - Facteurs favorisant l'apparition dans la crise d'asthme sont : sauf deux. Lesquels ?

- A Les agents toxiques inhalés
- B L'administration de médicament bronchodilatateur
- C L'exposition à une substance allergisant
- D l'humidité ou le froid
- E L'effort physique
- F La chaleur ou l'exposition au soleil

Q28 - Le plus souvent l'asthme est annoncé par des prodromes : sauf un. Lequel ?

- A Toux dyspnéique
- B rhinorrhée
- C état d'anxiété.
- D éternuements
- E céphalées
- F prurit

III - ETUDE DE CAS

(une réponse juste = 1 point – une réponse fausse = 0 point – une question sans réponse = 0)

Vous recevez à votre poste de consultation au centre de santé rurale de Kpebo le nourrisson BK âgé de 10 mois de sexe masculin. Accompagné de sa génitrice, l'enfant présente une éruption cutanée caractérisée par des macules rosées devenant une éruption papuleuse. L'enfant pleure beaucoup et se gratte constamment depuis plus de 24h.

A l'examen vous notez : des vésicules transparentes en gouttes de rosée. La vésicule est entourée d'une fine couche érythémateuse sur peau claire.

En 48h, la vésicule se dessèche avec un contenu trouble. La base de la vésicule reste souple.

Vers le 4^{ème} jour, apparaît une croûte brunâtre qui tombe vers le 10^{ème} jour.

Selon la mère, L'éruption est apparue d'abord sur la racine des cheveux, au thorax, les membres inférieurs et supérieurs puis le visage. se fait en plusieurs poussées.

La fièvre est de 38°C et le poids est à 10kg. On note quelques fois des adénopathies cervicales et une splénomégalie.

Tenant compte des données ci-dessus, répondez aux questions suivantes:

Q29. L'enfant BK présente : Choisir la bonne proposition

- A la scarlatine
- B la rougeole
- C la varicelle

Q30. Le germe en cause dans cette affection est : Cocher la bonne proposition

- A un virus
- B un parasite
- C une bactérie

Q31. Les symptômes décrits dans l'énoncé correspondent à la période Cocher la bonne proposition

- A D'incubation
- B D'invasion
- C D'état

D Des complications

Q32. Dans le suivi du malade vous informer sur les pratique suivantes : Cocher les pratiques d'évitement pertinentes

- A Eviter de boire de l'eau car risque d'hydratation excessive des vésicules
- B Eviter les crèmes et les pommades qui peuvent entraîner la surinfection par macération.
- C Eviter de laver l'enfant à l'eau et au savon car risque de propagation des boutons
- D Eviter de donner de l'aspirine sinon risque de syndrome de Reye qui peut entraîner une encéphalopathie.

Sur recommandation du Médecin chef de District de passage dans le Centre vous mettez l'enfant en observation pour 6 heures de temps sous une perfusion de 250 ml de sérum salé isotonique.

Q33. A quel débit moyen réglerez-vous cette perfusion : Cochez la bonne proposition

- A 14 gouttes / mn
- B 13 gouttes / mn
- C 12 gouttes / mn

Pour lutter contre la fièvre le Médecin vous recommande d'administrer du paracétamol injectable à raison de 45 mg/ Kg/ jours en trois dose fractionnées sur 24h. Le paracétamol injectable est livré en flacon 500 mg/ 5ml d'eau pour préparation injectable

Q34. Quelle est dose journalière en mg de paracétamol à administrer : Cocher la bonne proposition

- A 225 mg
- B 500 mg
- C 450 mg

Q35. Quelle est la dose fractionnée en ml de Paracétamol à prélever pour chaque injection: Cocher la bonne proposition

- A 5 ml
- B 4,5 ml
- C 1, 5 ml